

Flashcards ENARM -- Urgencias y Salud Pública

25 patologías · 138 tarjetas · generado 2026-09-12 por La Mole. Frente = pregunta tipo ENARM; Reverso = respuesta + dato diferencial.

Aborto

Tarjeta 1 -- FRENTE: Primigesta de 9 semanas con sangrado transvaginal, cólico leve y cérvix cerrado al examen con espéculo. ¿Diagnóstico y manejo inicial?

REVERSO: Amenaza de aborto (sangrado antes de la semana 22 sin dilatación cervical): reposo absoluto hasta 48 h después del cese del sangrado, ácido fólico, vigilancia con β -hCG cada 2-3 días y ultrasonido transvaginal semanal. Dato diferencial: en el aborto en evolución/inevitable hay contracciones, hemorragia y modificaciones cervicales (o ruptura de membranas).

Tarjeta 2 -- FRENTE: Mujer con amenorrea de 6 semanas y β -hCG plasmática de 2500 mUI/mL sin saco gestacional en ultrasonido transvaginal. ¿Qué debe descartarse?

REVERSO: Embarazo ectópico: con β -hCG >1500 mUI/mL el saco debe verse por vía transvaginal (>6500 por abdominal); su ausencia obliga a descartarlo. Dato diferencial: progesterona <5 ng/mL se asocia con muerte del producto.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Primera línea de tratamiento del aborto de ≤ 9 semanas con saco <24 mm.

REVERSO: Manejo médico con misoprostol (éxito ~95%, sin diferencia de eficacia con el quirúrgico a esta edad gestacional); en abortos ≥ 12 semanas el manejo de elección es la inductoconducción con prostaglandinas. Dato diferencial: el quirúrgico (LUI/AMEU) completa en un solo evento con éxito de 99%.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Dosis de misoprostol de elección para aborto incompleto o inevitable del primer trimestre por vía bucal.

REVERSO: 800 mcg vía bucal en dosis única (alternativas: 600 mcg VO o 400 mcg sublingual); se reduce a 200 mcg si el aborto es inevitable. Dato diferencial: en segundo trimestre se usan 400 mcg bucales/sublinguales cada 3 h hasta la expulsión.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Paciente con aborto, fiebre, dolor a la movilización cervical y escurrimiento fétido; laboratorio con hemólisis, bacilos grampositivos de extremos turgentes y gas intramiometrial. ¿Agente y manejo?

REVERSO: Aborto séptico por *Clostridium perfringens*: antibióticos combinados (ampicilina + gentamicina, o clindamicina + metronidazol) y evacuación quirúrgica 6-8 h después de iniciado el antibiótico. Dato diferencial: el gas intramiometrial con bacilos grampositivos turgentes es sugestivo de *C. perfringens*.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Gestante Rh-negativa de 15 semanas con amenaza de aborto. ¿Dosis de inmunoglobulina anti-D?

REVERSO: 300 μ g por vía intramuscular (>13 semanas); en <13 semanas corresponden 50-150 μ g IM. Dato diferencial: la anti-D se indica en toda paciente Rh-negativa con amenaza de aborto, sangrado o aborto completo.

Cardiopatía Isquémica Crónica (Angina Estable)

Tarjeta 1 -- FRENTE: Varón de 62 años con molestia precordial opresiva desencadenada por ejercicio y cediada en reposo. ¿Fármaco de primera línea para reducir los episodios?

REVERSO: Bloqueadores β (terapia inicial en ausencia de contraindicaciones); si están contraindicados o no se toleran, antagonistas de los canales de calcio o nitratos de acción prolongada. Dato diferencial: la nitroglicerina sublingual es solo para el alivio inmediato del episodio.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Alivio inmediato de la crisis anginosa en la cardiopatía isquémica crónica.

REVERSO: Nitroglicerina sublingual. Dato diferencial: la angina vasoespástica (Prinzmetal), que ocurre en reposo o por la noche, se beneficia más de nitratos y dihidropiridínicos.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Paciente anginoso que camina 1-2 cuadras en superficie plana y sube más de un piso en condiciones normales. ¿Clase de la clasificación CCS?

REVERSO: Clase III (limitación marcada de la actividad física ordinaria). Dato diferencial: en la clase II la limitación es ligera (camina más de 2 cuadras) y en la clase IV hay angina en reposo.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Anormalidad electrocardiográfica más frecuente en el ECG de la cardiopatía isquémica crónica.

REVERSO: Agudización y simetrización de la onda T, que significa isquemia subendocárdica. Dato diferencial: el estándar de oro anatómico es la angiografía coronaria invasiva; incluso con coronariopatía extensa el ECG en reposo puede ser normal.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Paciente con enfermedad arterial coronaria, diabetes y disfunción ventricular sistólica izquierda. ¿Qué grupos farmacológicos deben añadirse además del bloqueador β ?

REVERSO: IECA o ARA II (indicados con diabetes, disfunción ventricular sistólica y/o enfermedad renal crónica), estatina de alta intensidad y ácido acetilsalicílico en todos; inhibidor de SGLT2 si además hay insuficiencia cardíaca.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Angina que aparece espontáneamente en reposo o por la noche, sin provocación. ¿Diagnóstico y manejo farmacológico de preferencia?

REVERSO: Angina vasoespástica (Prinzmetal): mayor beneficio con nitratos y antagonistas dihidropiridínicos del calcio. Dato diferencial: la angina mediada por aumento de demanda (ejercicio) se beneficia más de bloqueadores β ; angina nueva en reposo anuncia posible SCA por ruptura de placa.

Embarazo Ectópico

Tarjeta 1 -- FRENTE: Mujer en edad reproductiva con amenorrea, dolor pélvico y sangrado transvaginal. ¿Localización más frecuente del embarazo ectópico y su relevancia?

REVERSO: Porción ampular de la salpinge (70%; >95% son tubáricos). Es la causa más común de muerte materna en el primer trimestre.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Método que confirma el diagnóstico de embarazo ectópico y su hallazgo característico.

REVERSO: β -hCG >1500 UI/L con útero vacío en ultrasonido transvaginal, con imagen de "anillo de fuego" con Doppler. Dato diferencial: un embarazo intrauterino no descarta un heterotópico, sobre todo tras fertilización in vitro.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Paciente hemodinámicamente estable, β -hCG de 2500 UI/L, saco de 30 mm sin latido cardíaco, sin dolor ni sangrado activo. ¿Tratamiento?

REVERSO: Metotrexato (con o sin ácido fólico): criterios GPC de β -hCG <3000 UI/L, saco <35-40 mm, ausencia de latido y sin sangrado intraabdominal activo. Dato diferencial: el manejo expectante exige además β -hCG <1000 UI/L en descenso, líquido libre <100 cc y masa anexial <2 cm.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Contraindicación relativa al metotrexato en el embarazo ectópico.

REVERSO: Saco gestacional >40 mm con actividad cardíaca embrionaria (las absolutas: lactancia, disfunción renal, hepática, pulmonar o hematológica, hipersensibilidad y enfermedad ácido-péptica). Dato diferencial: tras el metotrexato se exige anticoncepción efectiva por al menos 3 meses.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Triada clínica clásica del embarazo ectópico y su frecuencia.

REVERSO: Dolor, sangrado y masa anexial; solo se encuentra en 45% de los casos. Dato diferencial: la ruptura es una emergencia con mortalidad elevada y requiere evaluación ginecológica inmediata.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Indicaciones para realizar salpingectomía en lugar de salpingostomía.

REVERSO: Daño tubario, embarazo tubario recurrente, sangrado persistente, saco >5 cm, embarazo heterotópico con producto intrauterino viable, paridad satisfecha, no candidatas a metotrexato e inestabilidad hemodinámica. Dato diferencial: el bloqueo subaracnoideo o epidural está contraindicado si hay alteraciones de la coagulación.

Embarazo Múltiple

Tarjeta 1 -- FRENTE: Gemelos monocigóticos en los que la división ocurrió entre los días 8 y 12 posteriores a la fertilización. ¿Corionicidad y amnionicidad?

REVERSO: Monoamniótico monocoriónico (comparten placenta y saco amniótico). Dato diferencial: en los primeros 3 días son biamnióticos bicoriónicos; a los 4-8 días biamnióticos monocoriónicos; después de 12 días, siameses.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Ultrasonido de las 12 semanas que muestra tejido placentario entre las membranas de ambos sacos amnióticos. ¿Signo y corionicidad?

REVERSO: Signo Lambda: gestación bicorial. Dato diferencial: el signo de la T (sin tejido placentario entre las membranas) indica placenta compartida monocorial; la mejor ventana para determinarlo es entre las 11 y 13.6 semanas.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Gemelar monocorial con bolsillo mayor vertical ≤ 2 cm en un saco y ≥ 8 cm en el otro. ¿Diagnóstico y tratamiento de elección?

REVERSO: Síndrome de transfusión feto-fetal; tratamiento de elección: fetoscopia con coagulación láser de las anastomosis vasculares. Dato diferencial: se presenta en 10-15% de los embarazos gemelares monocoriales.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Hallazgos en el feto donante del síndrome de transfusión feto-fetal.

REVERSO: Hipovolemia, oliguria y oligohidramnios (el receptor cursa con poliuria, polihidramnios, insuficiencia cardíaca e hidropesía). Dato diferencial: el diagnóstico se establece por discordancia de líquidos amnióticos entre los fetos.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Diferencia de peso fetal estimado >25% entre gemelos. ¿Conducta?

REVERSO: Es un indicador clínicamente importante de restricción del crecimiento intrauterino: referencia al tercer nivel de atención. Dato diferencial: la discordancia de crecimiento se define por una diferencia de 15-25% del peso estimado.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Parto de gemelos en presentación cefálica-cefálica: vía preferida y momento de decidir cesárea.

REVERSO: Parto vaginal (éxito de 73%); si transcurren ≥ 30 minutos entre el nacimiento del primer y el segundo gemelo, cesárea. Dato diferencial: cefálica-no cefálica se individualiza (vaginal si pesan 1500-4000 g con obstetra experimentado) y no cefálica-otra es siempre cesárea.

Emergencias Obstétricas

Tarjeta 1 -- FRENTE: Gestante de 24 semanas con dolor en fosa iliaca derecha y sospecha de apendicitis aguda. ¿Estudio de primera elección?

REVERSO: Ultrasonido abdominal; ante duda diagnóstica se prefiere la resonancia magnética sobre la tomografía computarizada. Dato diferencial: el tratamiento de elección en cualquier trimestre es el abordaje laparoscópico.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Embarazada con sospecha de trombosis venosa profunda. ¿Debe solicitarse dímero D y cuál es el estudio de elección?

REVERSO: No: el dímero D está elevado por la propia gestación y no debe solicitarse; el estudio de elección es el ultrasonido por compresión. Dato diferencial: ante tromboembolismo pulmonar se inicia heparina de bajo peso molecular (enoxaparina) y continúa al menos 6 semanas posparto, con mínimo de 3 meses totales.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Gestante con fiebre, taquicardia y confusión por crisis tiroidea. ¿Fármacos para el control de la tormenta tiroidea?

REVERSO: Propiltiouracilo, solución saturada de yoduro de potasio, dexametasona y propranolol (paracetamol para el control térmico). Dato diferencial: el propiltiouracilo es de elección en el primer trimestre y a partir del segundo debe cambiarse a metimazol.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Gestante con hipotensión súbita, compromiso respiratorio y CID durante el alumbramiento, sin fiebre. ¿Diagnóstico y manejo?

REVERSO: Embolismo de líquido amniótico: diagnóstico clínico y por exclusión, asociado a hipoxemia y CID; solo medidas de sostén, con nacimiento inmediato si hay paro y >23 semanas. Dato diferencial: el estándar de oro es identificar constituyentes de líquido amniótico en la sangre materna (citoqueratina AE1/AE3 o azul de alcian).

Tarjeta 5 -- FRENTE: Primigesta con náuseas y vómitos incoercibles, pérdida de peso >5% del pregestacional y deshidratación. ¿Tratamiento de primera elección?

REVERSO: Antihistamínicos H1 (metoclopramida y ondansetrón son de segunda línea y los esteroides de tercera), más terapia hídrica, reposición de electrolitos y tiamina en casos graves. Dato diferencial: la hiperemesis gravídica exige descartar complicaciones con electrolitos, perfil tiroideo y hepático.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Durante el parto se palpa el cordón umbilical en el canal vaginal con desaceleraciones variables recurrentes. ¿Manejo inmediato?

REVERSO: Decúbito lateral en posición fetal (rodillas y cara al pecho) con elevación de la presentación (manual o llenado vesical con 500 ml), tocólisis temporal y cesárea de urgencia si el nacimiento vaginal no es inminente. Dato diferencial: las desaceleraciones variables recurrentes suelen ser el primer signo del prolapso de cordón.

Enfermedad Trofoblástica Gestacional

Tarjeta 1 -- FRENTE: Mola hidatidiforme con cariotipo 46 XX y ambos cromosomas X de origen paterno. ¿Tipo?

REVERSO: Mola hidatidiforme completa. Dato diferencial: la parcial es triploide (69 XXY en 80% de los casos), es la más frecuente en México y suele coexistir con un feto triploide defectuoso.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Ultrasonido obstétrico con patrón difuso ecogénico mixto en "tormenta o copos de nieve" y β -hCG muy elevada para la edad gestacional. ¿Diagnóstico y confirmación?

REVERSO: Mola hidatidiforme; la confirmación definitiva es el examen histopatológico del tejido (obligatorio estudiar los tejidos de toda evacuación uterina). Dato diferencial: el diagnóstico definitivo nunca es solo por imagen ni por β -hCG.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Tratamiento de elección de la enfermedad trofoblástica gestacional.

REVERSO: Histerectomía con preservación ovárica en casos seleccionados (disminuye 97% el riesgo de evolución maligna); con paridad insatisfecha, aspirado endometrial. Dato diferencial: está proscrita la inducción de trabajo de aborto en todo el espectro de la ETG.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Criterio de sospecha de malignidad tras la evacuación molar.

REVERSO: Meseta de β -hCG con fluctuaciones $\pm 10\%$ en cuatro mediciones (días 1, 7, 14 y 21), incremento $>10\%$ en tres mediciones (días 1, 7 y 14) o persistencia detectable de β -hCG a los 6 meses. Dato diferencial: cualquiera de estos criterios indica quimioterapia.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Gestante que desarrolla preeclampsia en la semana 16. ¿Qué debe sospecharse?

REVERSO: Enfermedad trofoblástica gestacional (mola hidatidiforme o coriocarcinoma): la altura uterina excede la amenorrea, hay quistes teca-luteínicos en un tercio y ausencia de latido cardíaco fetal. Dato diferencial: la preeclampsia de inicio temprano (14-20 semanas) apunta a enfermedad trofoblástica.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Puntuación de Berkowitz ≥ 4 tras la evacuación de una mola hidatidiforme. ¿Conducta?

REVERSO: Riesgo alto de neoplasia trofoblástica gestacional: quimioterapia profiláctica con actinomicina en dosis única. Dato diferencial: la NTG de pronóstico precario con metástasis se trata con EMA-CO (etopósido, metotrexato, actinomicina, ácido folínico, ciclofosfamida y vincristina).

Enfermedad Vascular Cerebral Hemorrágica

Tarjeta 1 -- FRENTE: Causa más común de hemorragia intracerebral espontánea.

REVERSO: Hipertensión arterial sistémica (siguen: traumatismos, diátesis hemorrágica, angiopatía amiloide y drogas ilícitas como anfetaminas y cocaína). Dato diferencial: en la HIC los síntomas pueden no ser máximos al inicio y progresan minutos-horas, a diferencia del inicio abrupto de la HSA.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Estudio de referencia para el diagnóstico de la hemorragia intracerebral aguda y fórmula para estimar el volumen del hematoma.

REVERSO: Tomografía computada simple (rápida, altamente sensible y específica) y fórmula ABC/2. Dato diferencial: la angio-TC debe realizarse de forma aguda en todos los pacientes, preferiblemente dentro de los 2 días posteriores a la TC sin contraste.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Paciente con hemorragia intracerebral bajo tratamiento con rivaroxabán. ¿Antídoto?

REVERSO: Andexanet alfa (inhibidores del factor Xa). Dato diferencial: dabigatrán-idarucizumab, heparina-protamina, y antagonistas de vitamina K: vitamina K IV 10 mg más concentrado de complejo de protrombina de cuatro factores con objetivo de INR <1.3 .

Tarjeta 4 -- FRENTE: Objetivo de presión arterial en la HIC con PA sistólica de 150-220 mmHg y síntomas de menos de 6 horas.

REVERSO: Reducirla a 130-140 mmHg, alcanzando la meta en una hora y sosteniéndola al menos una semana (vía IV: nitroglicerina o labetalol). Dato diferencial: evitar la reducción rápida si hay Glasgow <6 o evacuación neuroquirúrgica pendiente.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Hemorragia intracerebral cerebelosa de 4 cm de diámetro. ¿Manejo?

REVERSO: Evacuación descompresiva de la fosa posterior (indicada en HIC cerebelosa >3 cm o en hematomas menores con compresión del tronco encefálico o hidrocefalia obstructiva). Dato diferencial: también podrían beneficiarse los pacientes con Glasgow 10-13 y las hemorragias superficiales.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Cefalea súbita, instantánea y generalizada descrita como "el peor dolor de cabeza de su vida", con vómito e irritación meníngea. ¿Estudio inicial y conducta si es negativo?

REVERSO: Hemorragia subaracnoidea: TC simple dentro de las primeras 6 horas (sensibilidad 98% con cefalea en trueno aislada); si no es definitiva, punción lumbar: la xantocromía es patognomónica y >2000 eritrocitos en el tubo 4 obliga a angio-TC. Dato diferencial: todos los pacientes reciben nimodipino enteral y el aneurisma se asegura preferentemente por enrollamiento (coiling).

Enfermedad Vascular Cerebral Isquémica

Tarjeta 1 -- FRENTE: Paciente con EVC isquémico de 2 horas de evolución, candidato a trombólisis. ¿Dosis de alteplasa (rt-PA)?

REVERSO: 0.9 mg/kg intravenoso (máximo 90 mg), con bolo inicial del 10% de la dosis total en 1 minuto; indicada con <4.5 horas de evolución. Dato diferencial: en la ventana de 3-4.5 h se exige además edad <80 años, NIHSS <25, sin anticoagulantes orales y sin diabetes con infarto cerebral previo.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Único estudio de laboratorio obligatorio que debe preceder al inicio del rt-PA.

REVERSO: Glucosa sérica (excluye la trombólisis si <50 mg/dl). Dato diferencial: no debe demorarse la trombólisis ni la TC de cráneo por retrasos en el reporte de otros estudios de laboratorio.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Signos tempranos de infarto en la TC de cráneo sin contraste hiperaguda.

REVERSO: Signo de la arteria cerebral media hiperdensa, pérdida de la diferenciación sustancia gris-blanca (hipodensidad del núcleo lentiforme), pérdida de la cinta insular y borramiento de surcos. Dato diferencial: el puntaje ASPECTS >6 identifica candidatos a trombólisis o trombectomía; la RM-DWI detecta anomalías desde los 30 minutos.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Criterios de inclusión para trombectomía mecánica temprana.

REVERSO: Oclusión de la carótida interna o del segmento M1 de la cerebral media, <6 horas de evolución, NIHSS >6, ASPECTS >6, Rankin modificada 0-1 y edad >18 años. Dato diferencial: entre 6 y 24 horas se recomienda con criterios DEFUSE 3 o DAWN en circulación anterior con ASPECTS >6.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Meta de presión arterial durante las primeras 24 horas tras iniciar la trombólisis intravenosa.

REVERSO: Mantenerla <180/105 mmHg. Dato diferencial: si el paciente NO es candidato a trombólisis, solo se trata la PA si PAS >220 o TAD >120 mmHg, con reducción ≤15% de la basal (labetalol o nicardipino).

Tarjeta 6 -- FRENTE: Déficit neurológico completamente reversible en <1 hora, sin infarto en la imagen, con puntaje ABCD2 de 5. ¿Diagnóstico y conducta?

REVERSO: Isquemia cerebral transitoria de riesgo moderado-alto: admisión hospitalaria para abordaje urgente y antiagregación en las primeras 12-24 h (ABCD2 >4: aspirina 81 mg + clopidogrel 75 mg por 21-90 días, luego monoterapia). Dato diferencial: con ABCD2 <4 basta aspirina 50-325 mg/día o clopidogrel 75 mg/día.

Enfermedad Vascular Cerebral

Tarjeta 1 -- FRENTE: Definición de enfermedad vascular cerebral.

REVERSO: Episodio (o más) súbito de disfunción focal cerebral, de retina o médula espinal con duración >24 horas, o de cualquier duración si la imagen o la autopsia muestran infarto o hemorragia asociados. Dato diferencial: es una emergencia tiempo-dependiente; el retraso se asocia con menor recuperación y más complicaciones.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Tipo más frecuente de EVC incidente y su proporción.

REVERSO: Isquémico: 62% (la GPC refiere hasta 70%); la hemorragia intracerebral aporta 28% y la subaracnoidea 10%. Dato diferencial: la EVC hemorrágica en conjunto representa 20-30% de todos los EVC.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Los cinco factores de riesgo modificables que explican el 90% de los casos de EVC.

REVERSO: Hipertensión arterial, alimentación incorrecta, sedentarismo, obesidad y tabaquismo. Dato diferencial: el control multidimensional reduce en 80% el riesgo de nuevos eventos similares.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Riesgo aproximado de presentar un EVC a lo largo de la vida en adultos a partir de los 25 años.

REVERSO: Aproximadamente 25%; la EVC es la condición médica más importante que origina discapacidad neurológica permanente en el adulto. Dato diferencial: el riesgo se reduce con los 7 pasos cardiovasculares

(glucosa, colesterol, presión, tabaquismo, ejercicio 30 min tres veces por semana, peso y dieta saludables).

Epiglotitis

Tarjeta 1 -- FRENTE: Lactante febril con sialorrea, disfagia, distress respiratorio y voz de papa caliente, sentado inclinado hacia adelante con la boca abierta. ¿Diagnóstico?

REVERSO: Epiglotitis: los 4 D (Drooling, Disfagia, Distress respiratorio, Dysphonia) más postura tripódica. Dato diferencial: el crup cursa con tos perruna y sin sialorrea.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Agente etiológico clásico de la epiglotitis y la situación actual tras la vacunación.

REVERSO: Haemophilus influenzae tipo B, en declive por la vacuna anti-Hib; actualmente Streptococcus pneumoniae, S. pyogenes y S. aureus. Dato diferencial: la vacuna contra Hib la hace rara, pero sigue apareciendo.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Maniobra prohibida ante la sospecha de epiglotitis en un niño.

REVERSO: No usar depresor de lengua ni sedar: riesgo de obstrucción total de la vía aérea; la visualización e intubación se realizan en quirófano con equipo listo. Dato diferencial: el diagnóstico es clínico en el contexto correcto.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Hallazgo radiográfico característico de la epiglotitis.

REVERSO: Signo del pulgar (epiglotis engrosada) en la radiografía de cuello lateral. Dato diferencial: la confirmación y el manejo definitivo se hacen en quirófano.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Tratamiento de la epiglotitis y profilaxis de los contactos.

REVERSO: Primero proteger la vía aérea (intubación orotraqueal en quirófano con cirujano presente), ceftriaxona intravenosa y corticoesteroides para el edema; profilaxis a contactos con rifampicina. Dato diferencial: la vía aérea siempre antes del antibiótico.

Hemorragia Obstétrica

Tarjeta 1 -- FRENTE: Gestante de 31 semanas con sangrado vaginal indoloro y abundante de inicio súbito. ¿Diagnóstico más probable y estudio de elección?

REVERSO: Placenta previa (70% cursa con sangrado indoloro en el tercer trimestre); ultrasonido transvaginal, estándar de oro con sensibilidad cercana a 100%. Dato diferencial: el desprendimiento placentario cursa con sangrado doloroso, sensibilidad y tono uterinos aumentados.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Complicación característica del desprendimiento placentario y su mortalidad perinatal.

REVERSO: Coagulación intravascular diseminada (es la causa más común de CID en el embarazo); mortalidad perinatal de 35%. Dato diferencial: el desprendimiento se acompaña de sufrimiento fetal en 60% de los casos.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Desprendimiento placentario con muerte fetal. ¿Conducta?

REVERSO: Parto vaginal en ausencia de contraindicaciones, independientemente de la edad gestacional, con reposición agresiva de volumen y hemoderivados. Dato diferencial: los tocolíticos y relajantes uterinos están contraindicados; con producto vivo a término, cesárea.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Definición de hemorragia posparto y su causa más frecuente.

REVERSO: Pérdida ≥ 1000 ml o con signos de hipovolemia dentro de las 24 horas posparto; la atonía uterina causa ~70% (las 4 T: tono, tejido, trauma y trombina). Dato diferencial: los signos de hipovolemia no aparecen hasta perder >25% del volumen sanguíneo (>1500 ml al término).

Tarjeta 5 -- FRENTE: Uterotónico de primera elección en la hemorragia posparto y alternativa si está contraindicado.

REVERSO: Oxitocina IV o IM 10 UI; en HPP persistente se agrega ergonovina IM (contraindicada en estados hipertensivos del embarazo) o, en su defecto, misoprostol sublingual o rectal. Dato diferencial: el ácido tranexámico 1 g se administra dentro de las primeras 3 horas del evento, repetible a los 15 minutos.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Escalonamiento quirúrgico ante hemorragia posparto refractaria al tratamiento farmacológico.

REVERSO: Taponamiento con balón de Bakri → ligadura de vasos uterinos (desarterialización, técnica de Posadas) → ligadura de arterias ilíacas internas → histerectomía → empaquetamiento abdominal/embolización. Dato diferencial: la compresión bimanual es la medida mecánica temporal; el masaje uterino no se recomienda por carecer de utilidad demostrada.

Infarto Agudo de Miocardio con Elevación del ST

Tarjeta 1 -- FRENTE: Criterio electrocardiográfico diagnóstico del IAMCEST.

REVERSO: Nueva elevación del segmento ST en al menos 2 derivaciones contiguas: ≥ 0.1 mV en general; en V2-V3 > 0.25 mV en hombres < 40 años, > 0.20 mV en hombres > 40 y ≥ 0.15 mV en mujeres. Dato diferencial: un BRIHH nuevo o presumiblemente nuevo con dolor precordial equivale a IAMCEST y se valora con criterios de Sgarbossa (≥ 3 puntos).

Tarjeta 2 -- FRENTE: Infarto inferior: derivaciones electrocardiográficas y arteria responsable.

REVERSO: DII, DIII y aVF; la arteria coronaria derecha en 85% de los casos (circunfleja en 8%). Dato diferencial: el infarto de ventrículo derecho se evalúa con V3R y V4R, y el posterior con V7, V8 y V9.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Clase IV de Killip-Kimbal y su mortalidad hospitalaria.

REVERSO: Choque cardiogénico, con mortalidad hospitalaria de 81%. Dato diferencial: la clase III es edema agudo pulmonar (38%) y la clase II, S3 con estertores basales (17%).

Tarjeta 4 -- FRENTE: Tratamiento de reperfusión de elección en el IAMCEST y tiempos objetivo.

REVERSO: Intervención coronaria percutánea primaria: puerta-balón ≤ 60 minutos en centro con ICP (< 90 minutos si traslado) y no mayor de 120 minutos; si no es posible, fibrinólisis en las primeras 12 horas, idealmente en las primeras 2. Dato diferencial: tras fibrinólisis exitosa, angiografía en 2-24 horas; si fracasa (resolución del ST $< 50\%$ a 60-90 min), ICP de rescate.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Dosis de tenecteplasa para la fibrinólisis en el IAMCEST.

REVERSO: Bolo intravenoso en 10 minutos según peso: < 60 kg 30 mg; 60-70 kg 35 mg; 70-80 kg 40 mg; 80-90 kg 45 mg; > 90 kg 50 mg; reducir a la mitad en mayores de 75 años. Dato diferencial: la antiagregación de la ICP primaria es AAS 150-300 mg de carga más clopidogrel 600 mg de carga.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Complicaciones mecánicas del IAMCEST: momento de presentación, tipos y conducta.

REVERSO: Entre las primeras 48 horas y 14 días: rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo, del tabique interventricular e insuficiencia mitral aguda por rotura del músculo papilar; ante hipotensión súbita y nuevo soplo, ecocardiograma y tratamiento quirúrgico de elección. Dato diferencial: factores de riesgo incluyen infarto anterior y fibrinólisis tardía (> 12 h).

Infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)

Tarjeta 1 -- FRENTE: Estudio diagnóstico de la infección por VIH.

REVERSO: ELISA seguido de confirmación por Western blot; en el embarazo la prueba rápida es de primera línea y, si es negativa, se repite cada trimestre. Dato diferencial: en el niño expuesto menor de 18 meses el diagnóstico es por PCR (carga viral), pues los anticuerpos maternos inutilizan el ELISA.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Riesgo de transmisión perinatal del VIH sin tratamiento y con carga viral indetectable.

REVERSO: 22.6% sin TARV frente a 0.14% con carga viral indetectable; la transmisión periparto es la más frecuente (75% de los casos). Dato diferencial: la lactancia materna añade un riesgo de 7-22% y está contraindicada en mujeres con VIH.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Esquema de terapia antirretroviral recomendado en el embarazo.

REVERSO: TARV en todas las embarazadas con VIH sin importar CD4 o carga viral: antes de las 8 semanas, TDF/FTC + RAL; después de las 8 semanas, TDF/FTC o ABC/3TC + DTG. Dato diferencial: el dolutegravir en las primeras 8 semanas tiene riesgo potencial (no contraindicante) de alteraciones del tubo neural.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Indicaciones de cesárea electiva en la gestante con VIH y momento de programarla.

REVERSO: Semana 38, cuando la carga viral es >1000 copias/mL o desconocida, la paciente no recibe TARV o solo monoterapia con ZDV, o no acepta el parto vaginal. Dato diferencial: con carga viral <50 copias/mL puede considerarse parto vaginal con consenso del comité de cesáreas.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Profilaxis intraparto de elección en la madre con VIH.

REVERSO: Zidovudina intravenosa iniciada 4 horas antes de la resolución: infusión de 2 mg/kg en la primera hora y 1 mg/kg/hora hasta el nacimiento. Dato diferencial: la nevirapina no está recomendada como profilaxis intraparto.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Profilaxis del recién nacido de madre con VIH según el riesgo de exposición.

REVERSO: En las primeras 6-12 horas de vida: riesgo bajo, ZDV por 4 semanas; riesgo alto, ZDV + 3TC + NVP (ZDV/3TC por 4 semanas y NVP por 2). Dato diferencial: se descarta la infección con dos PCR negativas, una después del primer mes y otra después de los 4 meses de edad.

Isoinmunización al Factor Rh

Tarjeta 1 -- FRENTE: Mecanismo de la isoinmunización al factor Rh.

REVERSO: Madre Rh-negativa sensibilizada ante eritrocitos fetales Rh-positivos: produce IgG anti-D que cruza la placenta y destruye los eritrocitos fetales; habitualmente se requieren dos exposiciones al antígeno. Dato diferencial: la enfermedad aumenta de gravedad con cada embarazo.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Momentos de profilaxis rutinaria con inmunoglobulina anti-D en la gestante Rh-negativa no sensibilizada.

REVERSO: A las 28 semanas de gestación, en las 72 horas siguientes al parto de un producto Rh-positivo y ante cualquier evento con riesgo de hemorragia transplacentaria (aborto, embarazo ectópico, amniocentesis, trauma abdominal). Dato diferencial: no está indicada si el neonato es Rh-negativo o tiene Coombs directo positivo.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Dosis de inmunoglobulina anti-D según la edad gestacional.

REVERSO: <13 semanas: 50-150 µg intramusculares; >13 semanas: 300 µg intramusculares. Dato diferencial: si la prueba de Rosette posparto es positiva se calcula la dosis con Kleihauer-Betke (10 µg por cada ml de sangre fetal detectada).

Tarjeta 4 -- FRENTE: Herramienta más valiosa para detectar la anemia fetal en la isoinmunización.

REVERSO: Ultrasonido Doppler de la velocidad máxima en la arteria cerebral media fetal. Dato diferencial: produce falsos positivos después de la semana 35, por lo que puede recurrirse a la espectrofotometría del líquido amniótico.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Signos ultrasonográficos directos e indirectos de la hidropesía fetal.

REVERSO: Directos: halo cefálico doble, derrame pleural o pericárdico, hepatoesplenomegalia y ascitis; indirectos: polihidramnios, placentomegalia y aumento del diámetro de la vena umbilical. Dato diferencial: la hidropesía establecida elimina la necesidad de amniocentesis e indica intervención terapéutica.

Muerte Fetal

Tarjeta 1 -- FRENTE: Criterios de la OMS para definir la muerte fetal (óbito).

REVERSO: Muerte del feto antes de su expulsión o extracción completa, sin respiración, latido cardíaco, pulso del cordón ni movimientos voluntarios tras la separación; se establece desde las 22 semanas o peso >500 g. Dato diferencial: en México también se denomina óbito fetal.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Los tres datos clínicos que obligan a descartar la muerte fetal.

REVERSO: Ausencia de movimientos fetales, ausencia de crecimiento uterino y ausencia de frecuencia cardíaca fetal. Dato diferencial: acompañan regresión de los senos, desaparición de los síntomas neurovegetativos y de la telorrea.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Estudio de elección para confirmar la muerte fetal y primer signo radiográfico.

REVERSO: Ultrasonido en tiempo real; en radiografía el primer signo es el signo del halo (Damel), dentro de las 48 horas post mortem. Dato diferencial: el signo de Spalding (superposición de suturas craneales por licuefacción encefálica) aparece entre el día 1 y el 14.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Conductas terapéuticas ante la muerte fetal confirmada.

REVERSO: Manejo expectante (esperar trabajo de parto espontáneo) o intervencionista; dentro del intervencionista se prefiere la inducción para parto vaginal, salvo contraindicación materna (hemorragia, preeclampsia, cirugía uterina previa) o fetal (situación transversa) que indique cesárea. Dato diferencial: la causa se determina con autopsia, cariotipo y examen de placenta y cordón.

Parto Pretérmino

Tarjeta 1 -- FRENTE: Criterios diagnósticos del trabajo de parto pretérmino.

REVERSO: Contracciones uterinas (2 en 10 minutos, 4 en 20 u 8 en 60) más cambios cervicales documentados (borramiento >80% o dilatación ≥ 3 cm) entre las 22 y 36.6 semanas. Dato diferencial: las contracciones son un mal predictor; los cambios cervicales sí lo son.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Tocolítico de primera línea y limitación temporal de la indometacina.

REVERSO: Nifedipino (preferido por vía oral); la indometacina es de segunda línea y solo hasta las 32 semanas por el riesgo de cierre del conducto arterioso. Dato diferencial: la tocólisis dura 48 horas en >29 semanas y de 48 horas a dos semanas en <28, con índice de Gruber-Baumgarten <4.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Esquema de maduración pulmonar fetal en el parto pretérmino.

REVERSO: Betametasona 12 mg IM cada 24 horas por 2 dosis, o dexametasona 6 mg IM cada 12 horas por 4 dosis, entre las 24 y 36.6 semanas. Dato diferencial: reduce mortalidad, síndrome de dificultad respiratoria tipo I y hemorragia intraventricular.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Neuroprotección fetal en el parto pretérmino inminente.

REVERSO: Sulfato de magnesio entre las 24 y 31 semanas (puede considerarse hasta la 33.6). Dato diferencial: los antibióticos no prolongan la gestación; solo se indican como profilaxis de estreptococo del grupo B (penicilina o ampicilina) con parto inminente.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Conducta ante presentación pélvica en el parto pretérmino con peso fetal <1500 g.

REVERSO: El resultado neonatal mejora con cesárea. Dato diferencial: en presentación de vértice se prefiere el nacimiento vaginal, con fórceps y episiotomía para acortar el segundo estadio.

Puerperio

Tarjeta 1 -- FRENTE: Clasificación del puerperio según su tiempo de evolución.

REVERSO: Temprano (precoz o inmediato): primeras 24 horas; mediano: del segundo al séptimo día; tardío (remoto): del octavo día a la sexta semana (42 días). Dato diferencial: en el puerperio temprano puede ocurrir la complicación más grave, la hemorragia.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Secuencia de los loquios y el dato que sugiere endometritis.

REVERSO: Rojos los primeros días, serosos después de 3-4 días y alba hacia el décimo día; loquios malolientes sugieren endometritis. Dato diferencial: la secreción dura en promedio 24-36 días.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Peso uterino en la involución: a la semana, a las 2 semanas y a las 4 semanas posparto.

REVERSO: ≈500 g a la semana, ≈300 g a las dos semanas y ≈100 g a las cuatro (involución completa); la lactancia la favorece por liberación de oxitocina. Dato diferencial: el orificio cervical admite dos dedos solo durante los primeros 4-6 días.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Escala de tamizaje rápido de sepsis materna y sus criterios.

REVERSO: omqSOFA: ≥2 de presión arterial sistólica <90 mmHg, frecuencia respiratoria ≥25 rpm o cualquier alteración del estado de conciencia, asociados a un proceso infeccioso. Dato diferencial: la confirmación se hace con la omSOFA (>2 puntos), no con la SOFA convencional.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Tratamiento de la sepsis materna en la primera hora y vasopresor de elección en el choque séptico.

REVERSO: Antibiótico intravenoso empírico dentro de la primera hora (obtener cultivos previos sin retrasarlo) y cristaloides a 30 ml/kg en 3 horas; en choque séptico, norepinefrina para PAM >65 mmHg. Dato diferencial: las causas más frecuentes en el puerperio son las infecciones del tracto genital y la endometritis.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Criterio de fiebre puerperal por endometritis y esquema antibiótico empírico.

REVERSO: Temperatura >38 °C por más de 2 días consecutivos (excluyendo el primer día posparto) dentro de los primeros 10 días; tratamiento IV con gentamicina + cefotaxima + metronidazol. Dato diferencial: la fiebre en espigas por 7-10 días sugiere tromboflebitis pélvica y responde a heparina no fraccionada.

Ruptura Prematura de Membranas

Tarjeta 1 -- FRENTE: Definición de ruptura prematura de membranas y de su forma pretérmino.

REVERSO: Amniorrhexis antes del inicio del trabajo de parto, en cualquier momento de la gestación; la RPPM ocurre antes de las 37 semanas. Dato diferencial: la confirmación se hace con visualización directa del líquido en la vagina mediante espéculo estéril.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Pruebas complementarias para confirmar la RPM ante duda diagnóstica.

REVERSO: Prueba de nitrazina (sensibilidad 93%) y cristalografía (sensibilidad 88%); de última línea, instilación de índigo carmín. Dato diferencial: el tacto vaginal no debe realizarse sin trabajo de parto, por el riesgo de introducir infección.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Datos clínicos de corioamnionitis en una paciente con RPM.

REVERSO: Temperatura >37.8 °C, secreción vaginal fétida y frecuencia cardíaca fetal >160 latidos por minuto. Dato diferencial: con corioamnionitis establecida se indican antibióticos (ampicilina-gentamicina o clindamicina-gentamicina) e interrupción del embarazo.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Profilaxis antibiótica de la RPPM entre las 24 y 34 semanas sin corioamnionitis.

REVERSO: Ampicilina + eritromicina intravenosas por 48 horas, seguidas de amoxicilina y eritromicina orales por 5 días. Dato diferencial: la amoxicilina/ácido clavulánico no se recomienda por riesgo de enterocolitis necrotizante.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Manejo de la RPM a las 36 semanas de gestación.

REVERSO: Interrupción del embarazo: después de las 34 semanas no hay beneficio en prolongarlo. Dato diferencial: la tocólisis no está indicada en RPM (dato recurrente en el ENARM); ante corioamnionitis se interrumpe también entre 24-34 semanas.

Sepsis y Choque Séptico

Tarjeta 1 -- FRENTE: Definición de sepsis y de choque séptico (Sepsis-3).

REVERSO: Sepsis: disfunción orgánica potencialmente mortal por una respuesta desregulada del huésped a la infección; choque séptico: requiere vasopresores para mantener PAM ≥ 65 mmHg y lactato > 2 mmol/L pese a reanimación hídrica adecuada. Dato diferencial: el lactato > 2 mmol/L indica hipoperfusión incluso sin hipotensión franca.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Criterios de la escala qSOFA.

REVERSO: ≥ 2 de: frecuencia respiratoria ≥ 22 rpm, alteración del estado mental y presión arterial sistólica ≤ 100 mmHg. Dato diferencial: el qSOFA aplica principalmente fuera de la unidad de cuidados intensivos; el diagnóstico de sepsis se establece con incremento ≥ 2 puntos del SOFA sobre el basal.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Dos medidas que deben ejecutarse de inmediato ante sepsis.

REVERSO: Antibiótico empírico de amplio espectro dentro de la primera hora (obtener hemocultivos antes sin retrasarlo) y reanimación hídrica con cristaloides a 30 ml/kg en las primeras 3 horas. Dato diferencial: la etiología más frecuente es bacteriana gramnegativa (40%).

Tarjeta 4 -- FRENTE: Vasopresor de primera línea en el choque séptico.

REVERSO: Norepinefrina; de segunda línea, vasopresina o epinefrina; dopamina solo en casos seleccionados. Dato diferencial: la dopamina a bajas dosis con fin de protección renal es una práctica en desuso.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Indicación de corticoides en el choque séptico.

REVERSO: Hidrocortisona 200 mg/día, solo si el choque es refractario. Dato diferencial: dobutamina si hay disfunción miocárdica; insulina si la glucosa excede 180 mg/dL con meta < 180 mg/dL.

Síndrome Coronario Agudo sin Elevación del ST

Tarjeta 1 -- FRENTE: Paciente con dolor torácico nuevo en reposo, progresivo, sin elevación de troponinas ni CK-MB y sin supradesnivel del ST. ¿Diagnóstico?

REVERSO: Angina inestable; si las troponinas se elevan, infarto sin elevación del ST (bloqueo incompleto del flujo coronario). Dato diferencial: ambos integran el SCA sin elevación del ST, definido precisamente por la ausencia de elevación del segmento ST.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Biomarcadores de lesión miocárdica: cinética de troponinas y CK-MB.

REVERSO: Troponinas I/T aparecen a las 2-6 horas y persisten 5-14 días; CK-MB aparece a las 3-6 horas y persiste 2-4 días. Dato diferencial: la CK-MB es mejor para detectar reinfarto; las troponinas son falsamente positivas en insuficiencia renal crónica.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Variables de la escala TIMI en el SCA sin elevación del ST.

REVERSO: Siete variables de 1 punto: edad ≥ 65 años, ≥ 3 factores de riesgo, arteriopatía coronaria conocida, ≥ 2 anginas en las últimas 24 h, AAS en los 7 días previos, desviación del ST ≥ 0.5 mV y troponina/CK-MB elevadas. Dato diferencial: 5-7 puntos = riesgo alto con mortalidad de 21% a un año.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Tratamiento inicial de todo paciente con SCA sin elevación del ST sin contraindicaciones.

REVERSO: Ácido acetilsalicílico y clopidogrel, atorvastatina, antianginosos (nitroglicerina, bloqueadores β) y anticoagulación; los AINE están contraindicados. Dato diferencial: en riesgo alto se añade inhibidor de GPIIb/IIIa durante la ICP, anticoagulación más intensa y angiografía con revascularización.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Estrategia de revascularización según la anatomía coronaria en el SCA-SEST.

REVERSO: ICP con enfermedad de 1-2 vasos con lesión culpable, o multivazo con puntaje SINTAX < 13 ; cirugía de revascularización con SINTAX ≥ 13 y/o diabetes mellitus. Dato diferencial: la GPC recomienda la escala GRACE para estratificar el riesgo temprano (> 140 = riesgo alto, mortalidad hospitalaria $> 3\%$).

Tarjeta 6 -- FRENTE: Tratamiento prehospitalario del SCA recomendado por la GPC.

REVERSO: Reconocimiento y tratamiento de arritmias letales, oxígeno suplementario, ácido acetilsalicílico y nitroglicerina. Dato diferencial: en urgencias el ECG debe interpretarse en < 10 minutos y repetirse a las 6-8 horas si resultó normal.

Síndrome Neuroleptico Maligno

Tarjeta 1 -- FRENTE: Paciente tratado con haloperidol que a los 2 días cursa hipertermia de 39°C , rigidez generalizada, estupor, taquicardia e incontinencia. ¿Diagnóstico?

REVERSO: Síndrome neuroleptico maligno: reacción idiosincrática por bloqueo dopaminérgico central D2, con disfunción autonómica y motora; no es dosis-dependiente. Dato diferencial: el inicio es de 1-3 días tras la exposición o el cambio de dosis.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Dato clave de laboratorio del síndrome neuroleptico maligno.

REVERSO: CPK elevada > 1000 U/L, con rabdomiólisis, mioglobinuria, leucocitosis y elevación de transaminasas. Dato diferencial: los criterios mayores de Levenson son hipertermia, rigidez y CPK elevada; los menores, taquicardia, diaforesis, labilidad autonómica y alteración del sensorio.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Primera medida ante un síndrome neuroleptico maligno.

REVERSO: Suspensión inmediata del neuroleptico (medida crítica), seguida de hidratación intravenosa, enfriamiento físico y oxigenación. Dato diferencial: el antipsicótico no debe reiniciarse antes de 2-6 semanas, preferentemente con atípicos y vigilancia estrecha.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Tratamiento farmacológico específico del síndrome neuroleptico maligno con dosis.

REVERSO: Dantroleno 2.5 mg/kg IV (máximo 10 mg/kg/día) más bromocriptina 2.5-10 mg VO cada 6-8 horas; benzodiacepinas para sedación y relajación. Dato diferencial: la amantadina es alternativa dopaminérgica; los casos refractarios pueden requerir TEC o diálisis.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Paciente en tratamiento con ISRS y tramadol que en horas presenta hipertermia, mioclonías, hiperreflexia de miembros inferiores y diarrea. ¿Diferencial con el SNM?

REVERSO: Síndrome serotoninérgico: inicio en horas, hiperreflexia y mioclonías de arriba hacia abajo; el SNM inicia en días con rigidez en tubo de plomo de abajo hacia arriba. Dato diferencial: el antídoto serotoninérgico es la ciproheptadina, frente a dantroleno y bromocriptina del SNM.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Mortalidad del síndrome neuroleptico maligno sin tratamiento y tiempo de resolución.

REVERSO: 10-20% sin tratamiento; la resolución tarda 1-2 semanas (más si hubo neuroleptico de depósito). Dato diferencial: la mortalidad y el diagnóstico diferencial con golpe de calor, encefalitis o hipertiroidismo dependen del antecedente farmacológico.

Síndrome de Dificultad Respiratoria Aguda

Tarjeta 1 -- FRENTE: Criterios diagnósticos de Berlín para el SDRA.

REVERSO: Inicio dentro de 1 semana del insulto clínico, infiltrados bilaterales, edema no cardiogénico (PCWP <15 mmHg) y gravedad por PaO₂/FiO₂: leve 201-300, moderado 101-200 y grave ≤100 mmHg. Dato diferencial: una PaO₂/FiO₂ de 200-300 define daño pulmonar agudo, no SDRA.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Causa más frecuente de SDRA y ejemplos de causas indirectas.

REVERSO: Sepsis (la más frecuente); también pancreatitis, trauma no torácico, transfusión masiva y embolismo graso. Dato diferencial: entre las causas directas destacan la neumonía y la aspiración gástrica.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Diferencias radiográficas y hemodinámicas entre SDRA y edema pulmonar cardiogénico.

REVERSO: SDRA: infiltrados periféricos, silueta cardiaca normal y PCWP <15 mmHg; cardiogénico: infiltrados centrales, cardiomegalia y PCWP >18 mmHg. Dato diferencial: el broncograma aéreo es frecuente en el SDRA (80% frente a 25%).

Tarjeta 4 -- FRENTE: Parámetros de la ventilación mecánica protectora en el SDRA.

REVERSO: Volumen corriente de 6 ml/kg de peso ideal, presión meseta <30 cmH₂O y PEEP ajustada; en casos graves (PaO₂/FiO₂ <150), posición prona. Dato diferencial: el SDRA no mejora con diuréticos ni vasodilatadores porque el edema no es cardiogénico.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Complicaciones y mortalidad del SDRA.

REVERSO: Fibrosis pulmonar, neumotórax por barotrauma, infecciones nosocomiales y falla multiorgánica; mortalidad hasta 45% en el grave (leve ~27%, moderado ~32%). Dato diferencial: el ecocardiograma se usa para excluir el edema cardiogénico.

Síndrome Serotoninérgico

Tarjeta 1 -- FRENTE: Triada clínica del síndrome serotoninérgico (criterios de Hunter).

REVERSO: Neuromuscular: hiperreflexia, mioclonías, clonus y temblor; autonómica: hipertermia, taquicardia, midriasis, diaforesis y diarrea; mental: agitación y confusión. Dato diferencial: el patrón neuromuscular va de arriba hacia abajo, con mayor hiperreflexia en miembros inferiores.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Combinaciones farmacológicas que causan síndrome serotoninérgico en el examen.

REVERSO: ISRS o IMAO combinados con tramadol, triptanos o linezolida; también tramadol, linezolida, metadona y MDMA solos; el litio potencia el cuadro. Dato diferencial: el inicio es en horas, a diferencia del SNM que inicia en días.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Antídoto del síndrome serotoninérgico.

REVERSO: Ciproheptadina (antagonista 5-HT), acompañada de benzodiacepinas para la agitación. Dato diferencial: primero suspender el agente serotoninérgico y dar soporte (líquidos, enfriamiento, control de taquicardia e HTA).

Tarjeta 4 -- FRENTE: Diferencia clave del patrón neuromuscular entre síndrome serotoninérgico y síndrome neuroléptico maligno.

REVERSO: Serotoninérgico: hiperreflexia y mioclonías de arriba hacia abajo; SNM: rigidez "en tubo de plomo" de abajo hacia arriba. Dato diferencial: en el serotoninérgico la diarrea es frecuente y el fármaco causal es serotoninérgico (ISRS/IMAO/triptanos), no un bloqueador D2.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Orden de tratamiento del síndrome serotoninérgico.

REVERSO: Suspensión del agente serotoninérgico, benzodiacepinas para la agitación, ciproheptadina como antídoto y soporte general (líquidos, enfriamiento). Dato diferencial: tratarlo con dantroleno o bromocriptina (esquema del SNM) constituye un error diagnóstico clásico.

Trastornos Hipertensivos del Embarazo

Tarjeta 1 -- FRENTE: Criterios diagnósticos de preeclampsia.

REVERSO: Hipertensión $>140/90$ mmHg (≥ 2 tomas con margen de 4 horas) más proteinuria de 300 mg en orina de 24 h (o 1+ en tira reactiva, o relación proteína/creatinina $>0.28-0.30$), después de la semana 20. Dato diferencial: sin proteinuria, basta hipertensión más ≥ 1 dato de severidad (preeclampsia con criterios de severidad).

Tarjeta 2 -- FRENTE: Tres datos de severidad de la preeclampsia por sistemas.

REVERSO: Cardiovascular: TAS >160 o TAD >110 mmHg en 2 tomas; hematológico: plaquetas $<100,000$; renal: creatinina >1.1 mg/dl o elevación al doble de la basal. Dato diferencial: hepático, transaminasas al doble del rango superior; neurológico, cefalea, síntomas visuales o eclampsia.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Esquema de Zuspan de sulfato de magnesio para prevenir la eclampsia.

REVERSO: 4 g IV en 30 minutos seguidos de 1 g/hora; es de primera línea en preeclampsia con datos de severidad. Dato diferencial: ante recurrencia de convulsión, nueva dosis de 2-4 g IV en 5 minutos; alternativa ante contraindicación, fenitoína.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Crisis hipertensiva en preeclampsia (TAS ≥ 160 mmHg): fármaco de primera línea y dosis.

REVERSO: Nifedipino 10 mg VO cada 10-15 minutos (máximo 50 mg); segunda línea hidralazina IV y tercera labetalol IV. Dato diferencial: estas pacientes deben atenderse en unidades de cuidados intensivos.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Antihipertensivo oral de elección en preeclampsia sin crisis hipertensiva y fármacos prohibidos en el embarazo.

REVERSO: Alfametildopa 250-500 mg VO cada 8 horas (máximo 2 g/día); proscritos IECA, ARA-II, atenolol, prazosina y diuréticos por riesgo de muerte fetal y bajo peso. Dato diferencial: la única cura definitiva de la preeclampsia es la conclusión del embarazo.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Criterios diagnósticos del síndrome HELLP.

REVERSO: Hemólisis (esquistocitos en frotis, bilirrubina >1.2 mg/dl), elevación de enzimas hepáticas (AST >70 U/L o DHL >600 U/L) y plaquetas $<100,000/\mu\text{l}$. Dato diferencial: predomina en multíparas mayores de 25 años con <36 SDG; la hipertensión puede estar ausente en 20% de los casos.

Vacunas del Esquema Nacional - Descripción Individual

Tarjeta 1 -- FRENTE: Vacuna BCG: momento de aplicación, vía y protección que otorga.

REVERSO: Al nacimiento, intradérmica en deltoides derecho; previene las formas graves de tuberculosis (meningea y miliar). Dato diferencial: la hepatitis B también se aplica al nacimiento, pero intramuscular dentro de las primeras 24 horas.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Vacuna pentavalente: componentes y esquema de aplicación.

REVERSO: DPT + Hib + hepatitis B, aplicada a los 2, 4 y 6 meses por vía intramuscular en vasto lateral. Dato diferencial: la vacuna contra Hib es la que previene la epiglotitis.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Vacuna SPR: esquema y razón para no aplicarla antes de los 12 meses.

REVERSO: A los 12 meses con refuerzo a los 6 años, subcutánea (sarampión, rubéola y parotiditis); antes de los 12 meses interfiere con los anticuerpos maternos. Dato diferencial: los refuerzos de DPT y VOP se aplican a los 4 años.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Vacuna contra el VPH: población objetivo, esquema y enfermedad que previene.

REVERSO: Niñas y niños a los 11 años, 2 dosis; previene el cáncer cervicouterino. Dato diferencial: influenza y COVID-19 se aplican anualmente desde los 6 meses en grupos prioritarios.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Vacunas aplicadas a los 2 y 4 meses además de la pentavalente.

REVERSO: Rotavirus (vía oral) y neumocócica conjugada (intramuscular), con refuerzo neumocócico a los 12 meses. Dato diferencial: la del rotavirus previene diarrea grave y la neumocócica neumonía, meningitis y otitis.